

טיפול אנלגטי בכאבי בטן

בשנת 1957 פרסם רופא ושמו זכרי קופ (Sir Zachary Cope) נייר עמדה אשר לפיו מתן אנלגטיקה בכאבי בטן חריפים מעוות את הבדיקה הפיזיקלית ופוגע ביכולת האבחון של הקלינאי. עם השנים בוצעו כמה מחקרים שהפריכו טענה זו, ובשנת 2011 פורסמה סקירת קוקרן (Cochrane) הוא מאגר מידע מבוסס ראיות ברפואה) על שמונה מחקרים בנושא. הפרקטיקה היום יומית משתנה לאט, וגם כיום יש קלינאים שפועלים על פי אמונה תפלה זו. למען הסר ספק, **אין לעכב משככי כאבים אצל מטופל עם כאבי בטן אקוטיים.**

טיפול בכאבי בטן עם דימום ב־GI

מטופלים שסובלים מדימום חריף בדרכי העיכול (מתבטא בהקאה או בשלשולים עם דם אדום ובוהק) עלולים להידרדר למצב של הלם המורגי. במטופלים אלה יש לטפל על פי עקרונות ה־PHTLS (pre-hospital trauma life support), לפי הקטגוריה של דימום בלתי נשלט. יש לתת נוזלים בזרירות, לפי גישת permissive hypotension - שבה יש להגביל את מתן הנוזלים במצב של הלם המורגי בעקבות טראומה, כלומר יש לשמור על לחץ דם סיסטולי סביב 90 מ"מ כ"ס.

מטופלים עם הקאות בצורת קפה טחון (coffee ground) כלומר הקאות בצבע שחור כמו קפה, בדרך כלל לא מציינים סימני הלם המורגי בשטח, אך יש לשמור על עירנות וזהירות אם יש הקאות כאלה.

ניהול נתיב אוויר במטופל מקיא

מטופלים מקיאים הם מטופלים שנתיב האוויר שלהם אינו שמור. אם לחץ הדם מאפשר זאת, יש לפנות את המטופלים המקיאים בשיבה. כאשר לחץ הדם נמוך במיוחד יש להשכיב את המטופלים על הצד. אם מבוצעת אינטובציה יש להקפיד על הכללים האלה:

- מיגון מלא, כולל מסכה, מגן פנים, כפפות וחלוק
- הכנת שני סקשנים במקביל
- הרמת המטופל לתנוחה של 45 מעלות

הימנעות מאכילה ושתייה, צום (Nil Per Os: NPO)

כל מטופל שמלין על כאבי בטן חריפים וחריגים, גם ללא סימני גירוי פריטוניאליים ברורים, צריך להימנע מאכילה ושתייה, כלומר אסורה הכנסת מזון ושתייה דרך הפה (משמעות הביטוי הלטיני בתרגום לאנגלית היא: nothing by mouth). מטופלים אלו צריכים להפסיק לצרוך מזון ושתייה עד שכירורג ינחה שמתר.

כאבי צד, כאבים לומבריים (Flank Pain)

כאבים לומבריים (נקראים גם flank pains) אקוטיים בדרך כלל מסווגים לפי שלוש קטגוריות אטיולוגיות:

- כאבים ממקור שאינו כלייתי
- כאבים ממקור תוך־כלייתי
- כאבים בגלל ניקוז פתולוגי של שתן

טבלה 19.3 אטיולוגיה ואבחנה מבדלת לכאבי צד

מקור לא־כלייתי	מקור תוך־כלייתי	הפרעה בניקוז השתן
• גורם מוסקולוסקלטלי (שריר תפוס או שברים בצלעות 11 ו־12) • רדיקולופתיה (גורם עצבי מעמוד השדרה) (radiculopathy) • פלאוריטיס (דלקת בקרום הפלאורה) - קורה בדרך כלל בעקבות פנאומוניה או טוברקולוזיס (שחפת)	• אונטם כלייתי (renal infarction) • פילונפריטיס (דלקת כליות) • גידול בכליות	• אבנים בדרכי השתן (נפרוליתאזיס) • Stricture (היצרות דרכי שתן) • גורמים נוספים שמצרים את דרכי השתן

טיפול

הגורם הנפוץ ביותר לכאבים לומבריים (flank pains) הוא אבנים בדרכי השתן. בדרך כלל האבנים אינן חוסמות את הכליות, ומכאן שייצור השתן נמשך. אם יש חסימה כלייתית, התמונה הקלינית בדרך כלל סוערת בתצורת אורוספטיס. כך או כך, אבנים בכליות נוטות להוביל לכאב עצום, ויש לטפל בכך על פי פרוטוקול כאב, בדרך כלל עם אופיאטים.

- מעריכים ABC לפי הדגשים של טיפול בכאבי בטן
- יש לשלול אטיולוגיה קרדיאלית (אף על פי שאטיולוגיה זו אינה נפוצה בקשר של תלונה כזו)
- יש לשלול בטן חריפה
- מטפלים בכאב בהקדם האפשרי

כאבי גב, שלד ושרירים

כאבי גב תחתון

כאבי גב תחתון מוגדרים ככאבים בין קו הצלעות ובין קו העכוז. כאבי גב הם הסיבה השנייה בשכיחותה לביקור אצל רופא משפחה, וכ־80% מהאוכלוסייה יסבלו מכאבי גב חריפים לפחות פעם אחת בחייהם. בשל שכיחות כאבי הגב נוצרו מיתוסים בכל הנוגע אליהם. שלא כפי שנהוג לחשוב, גורם ספציפי לכאבים, כגון פריצת דיסק, היצרות של תעלת השדרה, שבר, זיהום או גידול קיים בכ־3% מכאבי הגב. ואילו 97% מכאבי הגב מסווגים ככאבים מכאניים לא ספציפיים, ובכ־85% מהמקרים אי אפשר להגיע לאבחנה ברורה של מקור הכאבים. יש מיתוסים רבים גם בכל הנוגע ספציפיות לפריצת דיסק. כ־90% מכלל פריצות הדיסק חולפים ספונטנית בתוך פרק זמן של שלושה חודשים. יתרה מזאת, כ־90% מכאבי הגב המכאניים חולפים בתוך כחודש. בשל ריבוי הגורמים לכאבי גב ובהיעדר יכולת לאבחן, התפקיד של מערכות הרפואה הדחופה והראשונית הוא שלילת מצבי סיכון, לכן חשוב להכיר את התמונה הקלינית ולזהות את נורות האזהרה.